

دعم الشخص التوحيدي أحادي التركيز عبر مراحل الحياة

دليل للممارسين والمتخصصين في الرعاية الصحية

الغرض. يشرح هذا الدليل ماهية العقل التوحيدي أحادي التركيز، وكيف تتغير خصائصه عبر مراحل الحياة، وكيف يمكن للممارسين والمتخصصين في الرعاية الصحية **التفاعل مع الأشخاص التوحيديين وتحفيزهم ودعمهم** من الطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة. يستند هذا الدليل إلى نظرية **أحادية التركيز (monotropism)** في التوحد — وهو تفسير قائم على الانتباه ومؤيد للتنوع العصبي طوره باحثون توحيديون هم ديناه ماري، وون لوسون، ومايك ليسر (2005) — وعلى الأدلة المراجعة من قبل الأقران وإرشادات الممارسة السريرية حيثما وجدت. هذا الدليل لا يحل محل التقييم الفردي؛ فكل شخص توحيدي مختلف عن الآخر.

ملاحظة حول اللغة. يستخدم هذا الدليل **لغة الهوية أولاً** ("شخص توحيدي")، وهي التفضيل لغالبية مجتمع التوحد وتتسق مع النظرية المصدر. يفضل بعض الأفراد والعائلات لغة الشخص أولاً ("شخص مصاب بالتوحد")؛ لذا يرجى اتباع تفضيل الفرد. يتجنب الدليل عمداً المصطلحات القائمة على العجز ("مضطرب"، "ناقص"، "عرض") إلا عند الاقتباس من المعايير السريرية، وبدلاً من ذلك يصف الاختلافات مع نقاط القوة والتحديات. أحادية التركيز هي إحدى العدسات؛ هناك أقلية من الأشخاص التوحيديين يشعرون أنها لا تصفهم، لذا يجب أن تكمل هذه النظرية عملية الاستماع إلى الفرد لا أن تحل محلها.

الجزء 1 — ما هو العقل التوحيدي أحادي التركيز؟

تقترح أحادية التركيز أن العقول تعمل ك **نظام اهتمامات**: نحن ننجذب إلى أشياء كثيرة، وهذه الاهتمامات تجذب انتباهنا، **والانتباه مورد محدود** تتنافس عليه العمليات العقلية (Murray, Lesser & Lawson, 2005). يتم تأطير الفرق بين الإدراك التوحيدي وغير التوحيدي على أنه فرق في كيفية تخصيص الانتباه، وليس عجزاً.

"في أي لحظة، تكون كمية الانتباه المتاحة للفرد الواعي محدودة. هناك تنافس بين العمليات العقلية على هذا المورد النادر." — Murray, Lesser & Lawson (2005). عبر الجمعية الوطنية للتوحد (NAS, 2025).

يميل العقل أحادي التركيز إلى إثارة عدد أقل من الاهتمامات في وقت واحد، ولكن كل اهتمام نشط يستحوذ على حصة كبيرة وكثيفة من موارد المعالجة، مما ينتج عنه "نفق انتباه" ضيق وعميق. كل ما يقع خارج النفق يتم معالجته بشكل أدنى. أما العقل متعدد التركيز (polytropic) (النمط الأكثر شيوعاً لدى غير التوحديين) فيوزع الانتباه على اهتمامات أكثر وينتقل بينها بسلاسة أكبر (Murray, Lesser & Lawson, 2005; F.). (Murray, 2018)

تقدم النظرية ثلاثة تنبؤات أساسية تنطبق على التجربة اليومية للتوحيدين (F. Murray, 2018; Dwyer, 2025; NAS, 2025):

1. **الكثافة داخل النفق** — تركيز حي وعميق يدعم الخبرة والإبداع وحالات التدفق (flow).
2. **انخفاض المعالجة خارج النفق** — قد لا يتم تسجيل المحفزات، والإشارات الاجتماعية، وحتى الإشارات الداخلية (الجوع، الألم، الحاجة إلى المرحاض).
3. **صعوبة الانتقال** — الانتقالات بين حالات الانتباه تكون بطيئة ومجهدة؛ وهذا ما يسمى **القصور الذاتي التوحيدي (autistic inertia)**.

1.1 الملف التعريفي للخصائص في لمحة

الخصائص المستندة إلى أحادية التركيز	المجال
تركيز عميق وضيق؛ مسارات متزامنة قليلة؛ "الاهتمامات الخاصة" مركزة ومبهجة وذات معنى، وليست هامشية	الانتباه / الاهتمام
فرط الاستجابة (المحفز المزعج الذي يتم التقاطه في النفق يُشعر به بكثافة)؛ نقص الاستجابة (عند الانغماس في مكان آخر، قد لا يتم تسجيل المحفزات/الألم)؛ السعي الحسي (السعي بكثافة وراء محفز مبهج داخل النفق) — تفسير موحد	الحواس
انخفاض الوعي بالجوع، العطش، الألم، التعب، أو الحاجة للمرحاض عند حالة التدفق ("انفصال الإدراك الداخلي")	الإدراك الداخلي والجسم
القصور الذاتي التوحيدي — صعوبة في البدء أو التوقف أو تغيير المسار؛ وليس "خللاً عاماً في الوظائف التنفيذية"	الانتقال / الوظائف التنفيذية
المعالجة الاجتماعية متعددة القنوات مكلفة؛ تفسير حرفي؛ الحاجة إلى وقت للمعالجة؛ مشكلة التعاطف المزدوج تعني أن سوء الفهم متبادل، وليس عجزاً توحيدياً	التواصل الاجتماعي
الروتين يقلل من القرارات المتنافسة والعبء العقلي؛ التحفيز الذاتي يوفر مدخلات يمكن التنبؤ بها والتحكم فيها تصفّي الحمل الزائد وتعيد التوازن	الروتين والتحفيز الذاتي (Stimming)

المجال	الخصائص المستندة إلى أحادية التركيز
نقاط القوة	الخبرة، اكتشاف الأنماط، التركيز المستدام، التدفق، الصدق، عمق المعرفة، الانغماس الإبداعي

1.2 مخاطر الرفاهية المترتبة على ذلك

إن فهم الآلية يجعل المخاطر متوقعة — والأهم من ذلك — قابلة للوقاية:

- **الانقسام أحادي التركيز (Monotropic split)** (مصطلح صاغته تانيا أدكين): التنافر العقلي والاستنزاف الناتج عن الإجبار على تقسيم الانتباه أو نقله بسرعة بطرق متعددة التركيز؛ "يمكن أن يكون له آثار كارثية على المدينين القصير والطويل" (F. Murray, 2023).
- **الانهيارات (Meltdowns) والانفلاقات (Shutdowns)** هي استجابات **لاإرادية** للجهاز العصبي تجاه الحمل الزائد، وليست خيارات سلوكية أو "نوبات غضب". **الانهيار** يكون ظاهراً (بكاء، صراخ، تحرك مستمر، تحفيز ذاتي، محاولات للهروب)؛ بينما **الانغلاق** هو المرأة الداخلية — انسحاب، عدم استجابة، انفصال، "إغلاق" وقائي للحفاظ على الطاقة (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism). كلاهما يتطلب وقتاً كبيراً **للتعافي** (أحياناً أياماً) ويزداد سوءاً بسبب عدم فهم الآخرين.
- **الاحتراق التوحدي (Autistic burnout)** هو "متلازمة ... ناتجة عن ضغوط الحياة المزمنة وعدم التوافق بين التوقعات والقدرات دون وجود دعائم كافية"، وتتميز بـ **إرهاق عام طويل الأمد (عادة 3 أشهر أو أكثر)، وفقدان في الوظائف، وانخفاض القدرة على تحمل المحفزات** (Raymaker et al., 2020). وهو يختلف عن **الاحتراق الوظيفي والاكتهاب السريري**، ويرتبط بـ **السلوك الانتحاري**، ويزداد سوءاً بسبب تعلم **المقنعة/التمويه (masking/camouflaging)** للسمات التوحدية. يرتبط التعافي بـ **القبول والدعم الاجتماعي، وأخذ وقت للراحة / تقليل التوقعات، وفعل الأشياء بطريقة توحدية** / **التخلي عن المقنعة** (Raymaker et al., 2020).
- **المقنعة / التمويه (Masking / camouflaging)** (إخفاء السمات التوحدية للظهور بمظهر غير توحدي) أمر مرهق ويرتبط بالقلق والاكتهاب وتأخر التشخيص — خاصة بين الفتيات والنساء اللواتي يتم توجيههن اجتماعياً للمقنعة بشكل أكبر (F. Murray, 2023; Pearson & Rose, 2021; Bradley et al., 2021).
- **الاجترار / "حلقات القلق"**: نفس التونيلينج الذي ينتج اهتماماً عميقاً يمكن أن يثبت على المخاوف والقلق (Hallett, 2021; F. Murray, 2023).

1.3 حالة الأدلة (كن صادقاً مع نفسك ومع عملائك)

تتلاقى أحادية التركيز بقوة مع الخبرات المعيشية للتوحيدين ويتم الاستشهاد بها بشكل متزايد في الأبحاث، ولكنها تظل نظرية **وصفية** مع اختبارات تجريبية مباشرة محدودة وقاعدة قياس غير ناضجة — **استبيان أحادية التركيز (Monotropism Questionnaire)** (Garau et al., 2023) هو الأداة المخصصة الوحيدة ولا يزال في طور التطور (Dwyer, 2021; Dwyer, 2025). تشمل الأدلة المتوافقة "بطء" فك الارتباط الانتباهي لدى الأطفال التوحيدين (Landry & Bryson, 2004; meta-analysis: Sacrey et al., 2015) وأدبيات ناشئة حول **التدفق التوحدي (autistic flow)** (Heasman et al., 2024). تعامل مع أحادية التركيز كإرشاد سريري قوي — وليس كملصق تشخيصي.

الجزء 2 — مبادئ عامة لكل ممارس

قبل أقسام المراحل العمرية، تنطبق هذه المبادئ **في كل مرحلة عمرية وفي كل بيئة**. وهي الجوهر العملي لـ "كيفية التفاعل مع" الشخص أحادي التركيز والتعامل معه بشكل جيد.

- 1. قابلهم حيث يوجد انتباههم.** إن أهم تداعٍ عملي لأحادية التركيز هو العمل مع اهتمام الشخص الحالي بدلاً من العمل ضده. الاهتمامات هي "رافعة" وليست عقبات يجب إعادة توجيهها (F. Murray, 2018; Wood, 2019; Lawson). **"عامل الاهتمامات كشيء تعمل معه"** (F. Murray, 2018).
- 2. احم نفق الانتباه؛ قلل من الانقسام أحادي التركيز.** تجنب المقاطعات، والتبديل القسري والسريع بين المهام، وتعدد المهام غير الضروري. عندما يكون الانتقال لا مفر منه، قدم **تحذيرات ووقتاً للانتقال** (انظر §3). كما يصف المهندس التوحدي جيمي نايت تخطيط مكان العمل: ابني **"أنفاقاً لا مهام"**، واجعل البيئة تفتح مساحة ليمر من خلالها النفق بدلاً من إجبار الشخص على الحفر من خلاله (Knight, 2021/2022).
- 3. احترم الاهتمامات العميقة كموارد للرفاهية.** توفر الاهتمامات الخاصة الفرحة والاستقرار والهوية والتعلم والتعافي من الاحتراق؛ فهي ليست "هوسات" يجب تقييدها (F. Murray, 2023; Mantzalas et al., 2022). تقليل الوصول إليها يشكل خطراً سريرياً وليس علاجاً.
- 4. قلل الحمل الحسي غير الضروري** وصمم بيئات سهلة الوصول (ضوضاء/فوضى بصرية أقل؛ توفير مساحات هادئة ذات إضاءة خافتة؛ تجنب وهج الفلورسنت والروائح القوية حيثما أمكن) (NAS, 2025; F. Murray, 2023).
- 5. تواصل بوضوح وبشكل حرفي.** قل ما تعنيه؛ تجنب السخرية والطلبات غير المباشرة والاعتماد المفرط على النبذة/التعبير وحده؛ **اسمح بوقت إضافي للمعالجة**؛ قدم المعلومات كتابياً. لا تعتبر الاستجابة البطيئة دليلاً على عدم الاهتمام أو عدم الفهم (F. Murray, 2023).

6. **مارس موقف التعاطف المزدوج.** أدرك أن انهيارات التواصل هي **ثنائية الاتجاه** (Milton, 2012). عندما يحدث خطأ في التفاعل، اسأل عما قد تكون أنت قد أغفلته، بدلاً من إرجاع الأمر إلى عجز الشخص التوحيدي.
7. **ادعم الاستقلالية والأصالة؛ لا تفرض المقنعة.** قلل الضغط للظهور بمظهر غير توحدي. قمع التحفيز الذاتي (stims) أو التواصل الطبيعي أمر ضار (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020; Pearson & Rose, 2021).
8. **ابن القدرة على التنبؤ والروتين مع الشخص، وليس عليه.** الروتينات المفروضة غالباً ما تأتي بنتائج عكسية؛ أما الروتينات التي يتم إنشاؤها بشكل تعاوني فتقلل من عبء اتخاذ القرار وتكون مرحباً بها (F. Murray, 2022).
9. **خطط للتعافي.** بعد الأحداث ذات الطلب العالي (زيارات العيادات، الانتقالات، المطالب الاجتماعية)، توقع واسمح بوقت للراحة، والتحفيز الذاتي، والوصول إلى الاهتمامات.
10. **استمع إلى الفرد كخبير في تجربته الخاصة.** التقرير الذاتي هو الدليل الأساسي؛ يمكن أن يكون استبيان أحادية التركيز (Garau et al., 2023) **فاتحاً للنقاش** مفيداً، وليس تشخيصاً.

الجزء 3 — دليل مراحل الحياة

يغطي كل قسم: (أ) ما قد تلاحظه، (ب) كيفية التفاعل، (ج) كيفية التحفيز / الإشراف، و (د) كيفية الدعم / التعامل مع التحديات.

3.1 الطفولة المبكرة (تقريباً 0-5 سنوات)

(أ) **ما قد تلاحظه.** تركيز مكثف على أشياء/مواضيع محددة؛ اهتمامات مكثفة تظهر مبكراً (غالباً تظهر في وقت أبكر مما تظهر لدى الأطفال غير التوحيدين)؛ ترتيب الأشياء، فرزها، تصنيفها وصنع الأنماط كنوع من اللعب؛ انخفاض أو عدم نمطية في الانتباه المشترك والاستجابة للاسم؛ **بطء في فك ارتباط الانتباه** ("نظرة ملتصقة") — يمكن قياسها منذ الرضاعة وهي من أوائل العلامات؛ فرط أو نقص في الاستجابة الحسية؛ روتينات ولعب تكراري؛ انهيارات عند الانتقالات. قد يكون الطفل التوحيدي أحادي التركيز مستغرقاً بعمق لدرجة أنه يفوت الكثير خارج النفق، بما في ذلك الجوع أو الألم أو مغادرة الوالد للغرفة (Landry & Bryson, 2004; F. Murray, 2023; Donzelli, 2021; Lawson, on object permanence).

(ب) **كيفية التفاعل.** ادخل نفق انتباه الطفل بدلاً من سحبه منه — **انضم إلى لعبه واهتمامه أولاً**، ثم توسع بلطف من هناك. استخدم الاهتمام لبناء الاتصال والانتباه المشترك (Lawson). اجعل اللغة واضحة وبطيئة وحرفية؛ اسمح بوقت للمعالجة؛ لا تفرض التواصل البصري (لأن التواصل البصري يمكن أن يستهلك موارد انتباه شحيحة في حد ذاته) (F. Murray, 2023). قلل الحمل الحسي في الغرفة.

(ج) كيفية التحفيز / الإشراف. استخدم الاهتمام المكثف للطفل كجسر للتعلم وبناء المهارات — يمكن ممارسة التسلسل، اللغة، العد، المهارات الحركية واللعب كل ذلك من خلال الاهتمام (Lawson; Wood, 2019; BERA, on flow states in the classroom). ادمع الانتباه المشترك الناشئ من خلال اللعب القائم على الاهتمام والعلاقات والتدخل المبكر (نموذج JASPER والنهج المماثلة القائمة على الاهتمام/اللعب تستهدف الانتباه المشترك واللعب الرمزي؛ Kasari et al., 2006). احترم ثقافة اللعب التوحدية — ترتيب الأشياء وفرزها والاستكشاف الحسي هي أنواع صالحة من اللعب، وليست لعباً "خاطئاً" يجب تصحيحه (Donzelli, 2021).

(د) كيفية الدعم / التعامل. أدر الانتقالات باستخدام جداول بصرية/مؤقتات، والعد التنازلي، والتحذيرات اللفظية والبصرية قبل التغيير، واستخدام "أشياء جسرية" للانتقال من نشاط إلى آخر، وإعطاء وقت إضافي؛ لا تسحب الطفل أبداً وبشكل مفاجئ من نفق الانتباه (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). بالنسبة **للانهيارات**: ابق هادئاً، قلل المحفزات، لا تحكم أو تعاقب — فهي لإرادية؛ ضمن السلامة، ثم اسمح بالتعافي (Autism Society, 2025). احم إمكانية الوصول إلى التحفيز الذاتي (فهو تنظيم ذاتي) (F. Murray, 2023). تجنب برامج الامتثال التي تدرب على إلغاء التحفيز الذاتي أو السلوكيات الطبيعية: هذه تزيد من المقنعة والضرب طويل الأمد (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).

3.2 سن المدرسة (تقريباً 6-12 سنة)

(أ) ما قد تلاحظه. المدرسة غالباً ما تكون أول اختبار مستدام للنظام أحادي التركيز وهي "جسيم للعديد من الأطفال أحادي التركيز — على الرغم من أن الكثير منا يحب التعلم" (F. Murray, 2023). الفصل الدراسي والممرات وأوقات الراحة عادة ما تكون **صاخبة جداً، ومزدحمة بصرياً وغير متوقعة**، مما يستهلك الانتباه الذي يجب أن يذهب للتعلم. قد يبدو الأطفال وكأنهم "يسيئون التصرف" عند الانتقالات، أو ينسحبون في أوقات الراحة، أو يتعرضون للتنمر بسبب اهتمامات "غريبة" أو لعب ذاتي التوجيه، أو يساء فهمهم من قبل الموظفين على أنهم متمردون أو كسالى أو غير مهتمين. يظهر القصور الذاتي في صعوبة بدء العمل، أو تبديل المواد، أو جمع الأدوات. يبدأ بعض الأطفال في المقنعة بشكل كثيف هنا، مع تكاليف على الصحة النفسية (F. Murray, 2023; Leatherland, 2019; NAS, 2025).

(ب) كيفية التفاعل (المعلمون، ممرضات المدرسة، المعالجون). أدرك أن المقاومة عند الانتقالات هي مشكلة **تكلفة معرفية** وليست تمرداً. وفر مساحات هادئة/ذات إضاءة خافتة (مثل "وظائف" المكتبة في وقت الراحة، أو ركن هادئ). ابنى علاقات من خلال اهتمام الطفل. تواصل بشكل حرفي ومسبق وكتابياً حيثما أمكن. نموذج موقف التعاطف المزدوج للأقران والزملاء — أطر الاختلافات كاختلافات، وليس كعجز (F. Murray, 2023; Wood, 2019).

(ج) كيفية التحفيز / الإشراف (المنهج أحادي التركيز). اجعل الاهتمام الخاص هو العمود الفقري للتعليم: علم القراءة والكتابة والرياضيات والتاريخ والعلوم من خلال الاهتمام؛ اسمح بوقت ممتد في حالة التدفق القائمة على الاهتمام؛ صمم المهام حول مسارات أقل وأعرق بدلاً من التبديل المستمر (Wood, 2019), "الاهتمامات المكثفة ... مفتاح الدمج التعليمي"; BERA, 2019; F. Murray, "Monotropism at School," حالات التدفق هي حالات تعلم — أحدها: "إذا كان الطالب يشعر بالارتباك ... وأنت تعلم أن لديه اهتماماً أحادي التركيز بـ Lego, فلماذا لا تنشئ مساحة هادئة ... وتسمح له بوقت ممتد" (BERA). تواصل مع المتعلم التوحدي الشغوف من خلال الشغف (Wood et al., 2022; Lawson).

(د) كيفية الدعم / التعامل. استخدم جداول زمنية بصرية، وتحذيرات من الانتقال وأنشطة جسدية؛ امنح وقتاً سخياً للانتقال وقلل عدد الانتقالات في اليوم قدر الإمكان (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). ابنِ روتينات بشكل تعاوني مع الطفل. راقب الاحتراق التوحدي و"تراجع المهارات" لدى الأطفال في سن المدرسة — هذه غالباً ما تعكس حملاً زائداً وتحولاً في موارد الانتباه، وليست فقداناً للقدرة الفطرية، والاستجابة تكون بتقليل المطالب واستعادة الوصول إلى الاهتمامات/الراحة، وليس بالضغط أكثر (Edgar, 2024; Raymaker et al., 2020). حدد وقلل ضغط المقنعة، خاصة لدى الفتيات اللواتي يتم تفويت تشخيصهن غالباً لأنهن يقمن بالمقنعة (F. Murray, 2023). استخدم دليلاً لاحتراق المعلمين (مثل Edgar, 2023) واستشر الوالدين خبراء في طفلهن.

3.3 المراهقة (تقريباً 13-18 سنة)

(أ) ما قد تلاحظه. يجلب البلوغ تغيرات هرمونية ودماعية (تقليم التشابكات العصبية، الميالين) التي يمكن أن تكثف الاستجابات الحسية والعاطفية وتعطل التوازن المستقر. المطالب الاجتماعية للمراهقة — التسلسلات الهرمية للأقران، القواعد الاجتماعية الضمنية، المواعيد، تكوين الهوية — هي عمليات عالية القنوات ومرهقة للنظام أحادي التركيز. تصل صعوبات الصحة النفسية (القلق، الاكتئاب) إلى ذروتها هنا؛ يمكن أن تصبح "حلقات القلق" متجذرة؛ وتكثف المقنعة، ويتم تحديد العديد من المراهقين التوحدين فقط في حالة الأزمة. تصبح الاهتمامات الخاصة مركزية للهوية وللتعافي. الصداقات، عندما تكون عالية الجودة، تكون وقائية للصحة النفسية (ARI, on puberty; Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023; Hallett, 2021; Sedgewick/Cook et al., via .(PMC9597130

(ب) كيفية التفاعل. تعامل مع الشاب كخبير في تجربته الخاصة. استخدم تواصلاً واضحاً وحرفياً ومحترماً؛ امنح وقتاً للمعالجة وخيارات مكتوبة. تحقق من شرعية الاهتمامات ودورها في تكوين الهوية. كن يقظاً لمشكلة التعاطف المزدوج في تفاعلات الأقران والأطباء. وفر القدرة على التنبؤ في المواعيد وقلل الحمل الاجتماعي/الحسي غير الضروري (Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023).

(ج) كيفية التحفيز / الإشراف. وجه الاهتمامات الخاصة نحو الدراسة والمشاريع والحقائب المهنية والتطوع واستكشاف المسار المهني المبكر — فهي أعظم أصول الشاب في التحفيز وبناء المهارات. ادعم الهوية والمجتمع: مجموعات الأقران التوحيديين، نوادي الاهتمامات الخاصة، الموجهون والمجتمعات التوحدية عبر الإنترنت يمكن أن تحول الرفاهية. علمهم الفهم الذاتي لأحادية التركيز حتى يتمكن الشاب من المطالبة باحتياجات انتباهه (بدلاً من استبطان فكرة "أنا كسول/محطم").

(د) كيفية الدعم / التعامل. عالج الصحة النفسية بشكل استباقي؛ افحص القلق والاكئاب والاحتراق والانتحار، مع إدراك أن الاحتراق التوحيدي يختلف عن الاكتئاب وعن الاحتراق الوظيفي ويتطلب تقليل المطالب، والقبول، والتخلي عن المقنعة، وليس مجرد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو مضادات الاكتئاب (Raymaker et al., 2020). ادعم الاحتياجات العملية والحسية المرتبطة بالبلوغ (الدورة الشهرية، النظافة، تغيرات الجسم) بشكل صريح وملحوس (ARI). عالج ضرر المقنعة — قلل صراحة من توقعات الظهور بمظهر غير توحيدي. علمهم إدارة الانهيارات/الانغلاقات ذاتياً وتأكد من وجود مسار تعافٍ منخفض المطالب للشباب. خطط للانتقالات إلى مرحلة البلوغ (التعليم، العمل، تسليم الرعاية الصحية) مبكراً وبوضع اهتمامات الشاب في المركز. (استنتاج، مُشار إليه: معظم الإرشادات السريرية هنا مستنبطة من أدبيات الاحتراق/المقنعة لدى البالغين والخبرات المعيشية التوحدية بدلاً من تجارب عشوائية محكمة خاصة بالمراهقين).

3.4 مرحلة البلوغ (تقريباً 19-منتصف العمر)

(أ) ما قد تلاحظه. العديد من البالغين التوحيديين — خاصة النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملونة وأولئك الذين ليس لديهم إعاقة ذهنية — يتم تشخيصهم فقط في مرحلة البلوغ ("الجيل المفقود"، Lai & Baron-Cohen). في البيئة المناسبة، يجلب البالغون أحادي المركز خبرة عميقة، وتركيزاً مستداماً، وموثوقية، واكتشافاً للأنماط وصدقاً هي أصول حقيقية. في البيئة الخاطئة — المكاتب المفتوحة، المقاطعات المستمرة، التوقعات غير الواضحة، الحمل الحسي، المطالب الاجتماعية-السياسية — يواجهون استنزافاً مزمنًا، ومقنعة، وانهيارات/انغلاقات، واحتراقاً توحيدياً (Knight, 2021/2022; Booth, 2021; Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022).

(ب) كيفية التفاعل. تواصل بشكل صريح وكتابياً؛ حدد التوقعات والمواعيد النهائية والمعايير الاجتماعية بشكل ملحوس بدلاً من تلميحها. اسمح بالتواصل المكتوب/غير المتزامن (البريد الإلكتروني، النصوص) مما يقلل من حمل القنوات. امنح وقتاً للمعالجة؛ لا تعتبر الصمت مقاومة. اسأل الشخص عن التسهيلات التي تساعد — فهو الخبير (F. Murray, 2023; Knight, 2021).

(ج) كيفية التحفيز / الإشراف (مكان العمل). صمم الدور الوظيفي حول أنفاق أقل وأعماق بدلاً من المهام (Knight, 2021): قلل الاجتماعات والمقاطعات، اجمع المهام الضحلة، اسمح بوقت التدفق، ووفر الوصول إلى مساحة هادئة/متحكم في حسياتها. طابق المهام مع نقاط القوة والاهتمامات الخاصة؛ إن كثافة التركيز التوحيدي، عندما يتم

حمايتها، هي أصل كبير للإنتاجية والابتكار (Advanced Autism Services, 2025; Sachs). **ابن روتينات** مع البالغ، واستخدم التسهيلات المتاحة قانونياً (Center; Booth, 2021). مثل (ADA/Equality Act) (Links ABA). شجع على **"العيش البسيط" (living little)** حيثما كان مفيداً — تبسيط الحياة في عدد قليل من مجالات التركيز يمكن أن يحسن الوظائف والسعادة بشكل ملحوظ (Knight, 2021).

(د) كيفية الدعم / التعامل. تعامل مع **الاحتراق التوحدي** ككيان سريري خطير ومميز: تعرف على الإرهاق المزمن، وفقدان المهارات التي كانت موجودة سابقاً، وانخفاض القدرة على تحمل المحفزات؛ قيم مخاطر الانتحار (Raymaker et al., 2020). اتجاه التعافي المدعوم بالأدلة هو **تقليل المطالب والتوقعات، وتوفير القبول والدعم الاجتماعي، والسماح بـ "فعل الأشياء بطريقة توحدية" / التخلي عن المقنعة** (Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022). لا تصف تدريب المهارات الاجتماعية القائم على المقنعة كحل. عالج القلق والاكتئاب المصاحب، وADHD، ومشاكل النوم والجهاز الهضمي (والتي هي أكثر شيوعاً لدى البالغين التوحديين). احترم أن **الاهتمامات الخاصة هي وقائية واستعادية**، وليست وسواسيات يجب تقييدها (Mantzalas et al., 2022).

3.5 كبار السن والمسنون (تقريباً 60 عاماً فأكثر)

(أ) ما قد تلاحظه — والحدود الصادقة لمعرفتنا. هذا هو الجزء الأقل بحثاً في حياة **التوحد**: حتى عام 2024، شكلت الأبحاث حول البالغين التوحديين المسنين حوالي 0.4% فقط من أدبيات التوحد (رغم نموها بنسبة ~392% منذ 2012) (Klein et al., 2024). ما يوجد من أدلة مثير للقلق: النتائج للبالغين التوحديين المسنين **سيئة بشكل عام** عبر جميع المجالات الأربعة لـ "الشيخوخة الجيدة" (الصحة والوظيفة؛ الوظيفة المعرفية والجسدية؛ العاطفة الإيجابية والسيطرة؛ المشاركة الاجتماعية). يظهرون **زيادة في الحالات الطبية، انخفاضاً في المهارات التكيفية، مخاطر مرتفعة من التدهور المعرفي، نشاطاً بدنياً محدوداً، معدلات عالية من حالات الصحة النفسية، جودة حياة منخفضة، ومشاركة اجتماعية/مجتمعية محدودة** (Klein et al., 2024). في عينة أسترالية واحدة (العمر +40)، استوفى 3.3% فقط معايير **"الشيخوخة الناجحة"** (Klein et al., 2024). يعاني البالغون التوحديون المسنون من **معدلات أعلى في معظم الحالات الصحية** — اضطرابات المزاج، مشاكل النوم، حالات الجهاز الهضمي والقلب — مقارنة بأقرانهم غير التوحديين (Additude, summarising population studies). العديد من المسنين التوحديين **غير مشخصين** ("الجيل المفقود")؛ يجب أن يكون السريريون مستعدين للتعرف على التوحد في المسنين الذين يظهرون اختلافات اجتماعية/حسية مدى الحياة، احتراقاً أو أزمة صحة نفسية (OAR; Klein et al., 2024).

(ب) كيفية التفاعل. تنطبق جميع المبادئ العامة بوزن إضافي: تواصل واضح وحرفي ومحترم؛ اسمح بوقت معالجة وفير ومعلومات مكتوبة؛ قلل الحمل الحسي (تغيرات السمع والبصر تزيد من الفروق الحسية الأساسية)؛ لا تفترض عدم القدرة المعرفية من استجابة بطيئة أو غير نمطية. ضع في الاعتبار **مشكلة التعاطف المزدوج** صراحة في إعدادات الرعاية.

(ج) **كيفية التحفيز / الإشراف.** حافظ على الاهتمامات الخاصة والروتينات مدى الحياة واحمهما — فهي مراسي للهوية والإدراك والرفاهية، وقد تكون وقائية بشكل خاص مع تغير القدرات الأخرى. كيف adapte الأنشطة وفقاً **للقدرة الجسدية والحسية المتغيرة** بدلاً من إزالتها. ادم **المجتمع والاتصال التوحيدي** لمواجهة العزلة الاجتماعية الشديدة التي تظهر في هذه المجموعة (Klein et al., 2024; OAR). شجع على النشاط البدني اللطيف المصمم للشخص (الخمول البدني مشكلة محددة) (Klein et al., 2024).

(د) **كيفية الدعم / التعامل.**

- **الوصول إلى الرعاية الصحية** فجوة حرجية: يتجنب العديد من المسنين التوحيدين الرعاية بسبب تجارب سلبية مدى الحياة وحواجز حسية/تواصلية؛ تحتاج العيادات إلى تدريب (OAR؛ انظر الجزء 4).
- **راقب الاحتراق التوحيدي** — يتراكم الخطر عبر عقود من المقنعة والاحتياجات غير الملباة، ويمكن أن يُقرأ خطأً كإكتئاب أو "تدهور مرتبط بالعمر" (Raymaker et al., 2020).
- **كن يقظاً لـ التغيير المعرفي مقابل الاختلاف التوحيدي:** التمييز بين أنماط أحادية التركيز/القصور الذاتي التوحدية وبين **الخرف/التدهور المعرفي** الحقيقي أمر صعب سريريًا وغير مدروس كفاية؛ لا تفترض. هناك أبحاث محدودة جداً حول التوحد + الخرف/الزهايمر — أشير إلى عدم اليقين وقيم بعناية (ABTABA; Klein et al., 2024).
- **بيئات الرعاية** (دور الرعاية، المستشفيات) غالباً ما تكون معادية حسياً ومزعجة للروتين؛ نادراً بتوفير مساحات هادئة، روتينات متوقعة، الاحتفاظ بالأشياء/الاهتمامات ذات المعنى، وتدريب الموظفين على التوحد.
- **ادعم تخطيط نهاية الحياة والتخطيط المسبق** بتواصل واضح وحرفي واحترام للاستقلالية.
- **استنتاج، مُشار إليه:** لأن الأدلة الخاصة بالتوحد في الشيخوخة شحيحة، فإن معظم هذا القسم يطبق نموذج أحادية التركيز مدى الحياة بالإضافة إلى نتائج عامة حول الشيخوخة مع التوحد؛ تعامل معه كإرشاد لأفضل الممارسات وليس كبروتوكول مثبت.

الجزء 4 — إرشادات محددة للمتخصصين في الرعاية الصحية

تعد إعدادات الرعاية الصحية (أضواء الفلورسنت الساطعة، فترات الانتظار غير المتوقعة، التعليمات الغامضة، المطالب الحسية والاجتماعية، الألم والتدخل) من أصعب البيئات للأشخاص أحاديي التركيز وغالباً ما تحفز الانغلاقات والانهيئات وتجنب الرعاية (Autism Society, 2025; PMC11305600 narrative review on autism-friendly

healthcare). ما يلي مستمد من أدبيات الرعاية الصحية الصديقة للتوحد ومجموعة أدوات الرعاية الصحية AASPIRE / أداة تسهيلات الرعاية الصحية للتوحد (AHAT) (autismandhealth.org).

قبل الزيارة

- **اعرض استبياناً قبل الزيارة / أداة AHAT** لالتقاط الاحتياجات الحسية والتواصلية والإجرائية المحددة للفرد وإنتاج تقرير تسهيلات مخصص (AASPIRE).
- **قدم معلومات مكتوبة وحرفية** عما سيحدث، وبأي ترتيب، وكم من الوقت سيستغرق؛ اعرض صوراً للغرفة/الموظفين إذا أمكن.
- **اعرض خيارات الجدولة:** الموعد الأول/الأخير (الأهدأ)، فترات انتظار أقصر، عدم التدخل مع عيادات صاخبة.
- **اسمح للشخص بـ إحضار داعم موثوق** ومجموعة أدواته الحسية (سماعات إلغاء الضوضاء، نظارات شمسية، أدوات تحفيز) (CHOP; Grateful Care ABA).

خلال الزيارة

- **قلل الحمل الحسي:** إضاءة خافتة أو ناعمة حيثما أمكن، تقليل الأصوات (beeping)، توفير غرفة هادئة، تجنب الروائح القوية/العطور (Autism Spectrum News; CHOP).
- **تواصل بشكل حرفي وملموس:** اشرح كل خطوة قبل القيام بها؛ قل ما تعنيه؛ تجنب التعبيرات المجازية؛ تحقق من الفهم بطلب إعادة صياغة من المريض؛ **اسمح بصمت طويل للمعالجة.**
- **لا تفرض التواصل البصري؛** اسمح للشخص بالنظر بعيداً، أو التحفيز الذاتي، أو التواصل كتابياً/بالطباعة/عبر AAC.
- **تحرك ببطء؛ اعرض فترات راحة.** وفر مجموعة أدوات تشتيت حسية (CHOP).
- **احترم نفق الانتباه:** إذا كان الشخص يستخدم اهتماماً أو تحفيزاً ذاتياً للتنظيم الذاتي أثناء إجراء ما، فلا تقاطعه.
- **طبق موقف التعاطف المزدوج** (Milton, 2012; Neurodivergent Insights): إذا تعثر التواصل، افترض وجود فجوة متبادلة وتكيف، بدلاً من وصف المريض بأنه "صعب" أو "غير ممثّل".

بعد الزيارة

- **قدم متابعة مكتوبة** (التشخيص، التعليمات، الخطوات التالية) بلغة حرفية.
- **حدد وقت للتعافي** وحذر من أن الشخص قد يحتاج إلى الراحة/الانغلاق بعد الزيارة.
- **وثق التسهيلات الفعالة** في السجل بحيث تكون تلقائية في المرة القادمة.

إدراكات سريرية حرجة

- **الاحتراق التوحدي ليس اكتئاباً.** يظهر كإرهاق مزمن، وفقدان للمهارات، وانخفاض القدرة على تحمل المحفزات، مدفوعاً بحمل تراكمي وعدم توافق بين التوقعات والقدرات؛ التعامل معه كإكتئاب (أو دفع المريض لـ "المحاولة بجدية أكبر") يمكن أن يعمقه ويزيد من مخاطر الانتحار. يتطلب التعافي تقليل المطالب، والقبول، والإذن بالتخلي عن المقنعة (Raymaker et al., 2020).
- **المقنعة في العيادة شائعة ومكلفة.** المريض الذي "يبدو بخير" في موعد مدته 15 دقيقة قد يكون يمارس التمويه ويدفع الثمن لاحقاً؛ لا تدع المظهر المقنع يلغي التقرير الذاتي أو التاريخ المرضي (Pearson & Rose, 2021; F. Murray, 2023).
- **الألم والإدراك الداخلي.** قد لا يلاحظ الشخص أحادي التركيز أو يبلغ عن الألم، الجوع، العطش، التعب أو الأعراض الداخلية حتى تصبح شديدة (Kelly Mahler, 2024; Lawson). لا تعتبر "عدم الشكوى" دليلاً على "عدم المعاناة"؛ اسأل بشكل استباقي، واعتبر أن أنماط الأعراض المبلغ عنها قد تكون متأخرة أو غير نمطية.
- **الأدوية والآثار الجانبية.** يبلغ التوحيديون تكراراً عن استجابات حسية وعاطفية غير نمطية للأدوية؛ ابدأ بجرعة منخفضة، زدها ببطء، وراقب التقرير الذاتي بعناية.
- **الانهيار/الانغلاق في العيادة.** هذه استجابات لإرادية: قلل المحفزات، خفض المطالب، ضمن السلامة، امنح الوقت والمساحة، لا تقيد أو تعاقب؛ الانغلاق يحتاج إلى صبر هادئ ومنخفض المدخلات، وليس ضغطاً "للتفاعل" (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism).
- **الموافقة والأهلية.** قدم المعلومات بشكل ميسر وحرفي؛ اسمح بوقت للمعالجة واتخاذ القرار المدعوم؛ لا تفترض عدم الأهلية من التواصل غير النمطي.
- **التسهيلات تفيد الجميع.** الرعاية الصديقة للحواس، والمتوقعة، والمصاغة بوضوح تفيد أيضاً المرضى المصابين بـ ADHD، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والقلق، وفقدان الحواس، والتغير المعرفي، وكثيرين آخرين (UNC Health, 2025).

الجزء 5 — ما يجب تجنبه (أضرار شائعة)

- سحب الشخص فجأة من نفق الانتباه أو مقاطعة التدفق بشكل متكرر (F. Murray, 2023).
- التدريب على إلغاء التحفيز الذاتي أو اختلافات التواصل البصري أو التواصل الطبيعي (الـ "تطبيع" القائم على الامتثال) — يزيد من المقنعة والضرر طويل الأمد (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).
- تأطير الاهتمامات الخاصة كـ "هوسات" يجب تقييدها؛ أو تقليل الوصول إليها (Mantzalas et al., 2022).

- فرض الروتينات/التوقعات على الشخص بدلاً من إنشائها بشكل تعاوني (F. Murray, 2022).
- استخدام لغة قائمة على العجز أو مرضية؛ إرجاع جميع مشاكل التفاعل إلى الشخص التوحدي (Milton, 2012).
- معاملة الاحتراق التوحدي كإكتئاب أو كسل؛ دفع الشخص للمزيد من المقنعة (Raymaker et al., 2020).
- العيادات المعادية حسيًا، الإجراءات المفاجئة، والتعليمات الغامضة (PMC11305600; AASPIRE).
- افتراض أن اختلافات البالغ المسن مدى الحياة هي "مجرد شيخوخة" أو خرف دون تقييم مناسب (Klein et al., 2024).

الجزء 6 — أسئلة مفتوحة وتحذيرات من الأدلة (للممارسة الصادقة)

1. **الشيخوخة فجوة بحثية.** معظم إرشادات مدى الحياة للمسنين مستنبطة؛ الرعاية في نهاية الحياة، والتوحد + الخرف، والتوحد + سن اليأس/سن اليأس للرجال، غير مدروسة إلى حد كبير (Klein et al., 2024). كن شفافاً بشأن عدم اليقين مع المرضى والعائلات.
2. **أحادية التركيز وصفية، وليست ميكانيكية أو مختبرة بالكامل بعد.** هي إرشاد سريري ممتاز مع دعم متزايد، ولكنها ليست تشخيصاً أو نظرية كاملة (Dwyer, 2021; 2025).
3. **ليس كل التوحدين أحادي التركيز.** هناك أقلية لا تحدد نفسها بهذا الإطار؛ اجعل الفرد دائماً هو المركز (monotropism.org).
4. **التقاطعية غير معالجة كفاية.** معظم الأبحاث منحازة للبشر البيض، الغربيين، اللغظيين، وذوي الاحتياجات المنخفضة؛ تختلف العروض والتشخيص والاحتياجات عبر النوع الاجتماعي، العرق، القدرة الذهنية وملفات التواصل (Raymaker et al., 2020 limitations).
5. **التزامن هو القاعدة.** يظهر (ADHD (AuDHD، والقلق، والاكتئاب، واختلافات التعلم، وحالات الجهاز الهضمي/النوم بشكل شائع؛ قد تساعد أحادية التركيز في تفسير تداخل AuDHD، ويسجل استبيان أحادية التركيز أعلى الدرجات لدى (AuDHD (Garau et al., 2023; NAS, 2025).

المصادر

1. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2),

- 139–156. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398> — via <https://monotropism.org/murray-lesser-lawson>
- Murray, F. (2018, updated 2025). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist*, BPS. <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> .2
- Murray, F. (2023). Monotropism and Wellbeing (keynote, Scottish Autism Research Group 2023). <https://monotropism.org/wellbeing> .3
- Murray, F. (2019). Monotropism at School (originally in *Tes*). <https://monotropism.org/school/> — indexed at <https://monotropism.org/in-practice> .4
- Murray, F. (2022). Understanding how routines can help autistic people thrive. *Thinking Person's Guide to Autism*. <https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html> .5
- National Autistic Society (Edgar, H. & Adkin, T., 2025). What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism. <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> .6
- Dwyer, P. (2021). Revisiting monotropism. *Autistic Scholar*. [/https://www.autisticscholar.com/monotropism](https://www.autisticscholar.com/monotropism) .7
- Dwyer, P. (2025). Monotropism: between obsessive joy and overwhelm. OTARC Blog, La Trobe University. <https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm> .8
- Garau, V. et al. (2023). Development and validation of a novel self-report measure of monotropism (the Monotropism Questionnaire). OSF preprint. <https://osf.io/ft73y/> — tool at [/https://dlcincluded.github.io/MQ](https://dlcincluded.github.io/MQ) .9
- Landry, R. & Bryson, S. (2004). Impaired disengagement of attention in young children with autism. *J Child Psychol Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x> .10
- Sacrey, L.-A. et al. (2015). Attention disengagement in autism spectrum disorder: a meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*, 56, 111–121. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011> .11

- Heasman, T. et al. (2024). Autistic flow theory. (Cited in NAS, 2025.) .12
- Raymaker, D. M. et al. (2020). "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32851204> — full text: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378 .13
- Mantzas, J. et al. (2022). A conceptual model of risk and protective factors for autistic burnout. *Autism Research*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2722> .14
- Pearson, A. & Rose, K. (2021). A conceptual analysis of autistic masking: understanding the narrative of stigma and the illusion of choice. *Autism in Adulthood*, 3(1). <https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/aut.2020.0043> .15
- Bradley, L. et al. (2021). Autistic adults' experiences of camouflaging and its perceived impact on mental health. *Autism in Adulthood*, 3(4), 320–329. (PubMed 36601637.) .16
- Milton, D. (2012). On the epistemic and ontological value of the double empathy problem. *Dis & Soc*. Summary: Reframing Autism, <https://reframingautism.org.au/miltons-double-empathy-problem-a-summary-for-non-academics> .17
- Lawson, W. (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley. — and Lawson, W. (2025). Research by autistic researchers: an 'insider's view' into autism. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. [/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063) .18
- Wood, R. (2019). Autism, intense interests and support in school: from wasted efforts to shared understandings. *Educational Studies*. Summary: <https://woodbug.blog/2019/03/27/autistic-children-and-intense-interests-the-key-to-their-educational-inclusion> .19
- Wood, R. et al. (2022). *Learning From Autistic Teachers*. Jessica .Kingsley .20
- Leatherland, J. (2019). Understanding how autistic pupils experience secondary school (PhD thesis, Sheffield Hallam). [/http://shura.shu.ac.uk/23231](http://shura.shu.ac.uk/23231) .21

Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: a randomized controlled intervention study. <i>J Child Psychol Psychiatry</i> , 47, 611–620. (Referenced via PMC5683273.)	.22
Donzelli, S. (2021). Autistic play at forest school: pretend play characteristics seen otherwise. <i>Forest School Association</i> . https://forestschoollassociation.org/autistic-play-at-forest-school-/pretend-play-characteristics-seen-otherwise	.23
Hallett, S. (2021). Loops of concern (guide on autistic rumination). https://medium.com/@sonyahallett/loops-of-concern-ff792eebad03	.24
Kelly Mahler (2024). Interoception and monotropism. https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-/monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences	.25
Knight, J. (2021). Staying put, monotropism & me (tunnels not tasks); (2022) Applying monotropism. https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me	.26
Booth, J. (2021). Why does work not work for autistic people? https://janinebooth.com/content/why-does-work-not-work-autistic-people	.27
BERA (2021). Autism: the benefits of monotropism and flow states and its applications for the classroom. https://www.bera.ac.uk/blog/autism-the-benefits-of-monotropism-and-flow-states-and-its-applications-for-the-classroom	.28
Autism Society (2025). Autistic meltdowns and shutdowns / (factsheet). https://autismsociety.org	.29
Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. Understanding autistic meltdowns and shutdowns. https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns	.30
Reframing Autism. All about autistic shutdowns: a guide for allies. https://reframingautism.org.au/all-about-autistic-shutdown-guide-for-allies	.31
AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT). https://autismandhealth.org	.32

Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). Tips for more positive office visits for patients with ASD. https://www.chop.edu/news/tips-more-positive-office-visits-patients-asd	.33
UNC Health (2025). Autistic patients need better care, accommodations in the medical office. https://news.unchealthcare.org/2025/04/autistic-patients-need-better-care-accomodations-in-the-medical-office	.34
Autism Spectrum News. Creating sensory-friendly health care environments for autistic patients. https://autismspectrumnews.org/creating-sensory-friendly-health-care-environments-for-autistic-patients	.35
Klein, C. B. et al. (2024). Aging well and autism: a narrative review and recommendations for future research. <i>Healthcare</i> , 12(12), 1207. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11203987 — https://doi.org/10.3390/healthcare12121207	.36
Organization for Autism Research (OAR). Aging on the autism spectrum. https://researchautism.org/oaracle-newsletter/aging-on-the-autism-spectrum	.37
Lai, M.-C. & Baron-Cohen, S. (2015). Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. <i>Lancet Psychiatry</i> . (Referenced in Klein et al., 2024.)	.38
Edgar, H. (2023). Supporting pupils through autistic burnout (teacher guide). https://autisticrealms.com/supporting-pupils-through-autistic-burnout-teacher-guide	.39
Edgar, H. (2024). Autistic young people: skills regression, burnout or a shift in monotropic attentional resources? https://autisticrealms.com/autistic-young-people-skills-regression-burnout-or-a-shift-in-monotropic-attentional-resources	.40
Autism Awareness Australia. Understanding mental health in autistic teenagers. https://www.autismawareness.com.au/navigating-autism/understanding-mental-health-in-autistic-teenagers	.41
Autism Research Institute (ARI). Understanding and supporting puberty in autistic girls and boys. https://autism.org/understanding-and-supporting-puberty	.42

Neurodivergent Insights. Autism and the double empathy problem in medicine. <https://neurodivergentinsights.com/the-double-empathy-problem-in-medicine> .43

PieBru (2025). Monotropism: an interest-based account of autism (source brief). <https://github.com/PieBru/monotropism/blob/main/monotropism.md> .44

Narrative review: Autism-friendly healthcare — a narrative review of the literature (PMC11305600). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11305600> .45

موارد عملية داعمة (مذكورة في المتن أعلاه للبيانات العملية منخفضة المخاطر)

Advanced Autism Services (2025). How to support autistic adults in the workplace. <https://www.advancedautism.com/post/how-to-support-autistic-adults-in-the-workplace> •

Sachs Center. Autism workplace accommodations that actually work. <https://sachscenter.com/autism-workplace-accommodations> •

Links ABA. Accessing healthcare as an autistic individual; work and mental health tips for autistic adults. <https://linksaba.com> •

Autism Little Learners. Transitions and autism; smoother transitions in young autistic kids. <https://autismlittlelearners.com> •

Grateful Care ABA. Preparing for doctor visits with autism. <https://www.gratefulcareaba.com/blog/preparing-for-doctor-visits-with-autism> •

ABTAB / Above and Beyond Therapy. Autism aging out; autism shutdown. <https://www.abtaba.com> •

Additude. Aging with autism: cognition, health, loneliness & other factors. <https://www.additudemag.com/aging-with-autism-research> •

Retireguide. Aging with autism: a seniors & caregivers guide. <https://www.retireguide.com/guides/seniors-autism-spectrum> •

Raising Children Network (Australia). Self-identity for your autistic teen. <https://raisingchildren.net.au/autism> •

Autistic Realms (Edgar, H.). Monotropism = happy flow state. <https://autisticrealms.com/monotropism-happy-flow-state> •

Neurodiverse Connection. Embracing autistic children's monotropic flow states.

<https://ndconnection.co.uk/blog/embracing-autistic-childrens-monotropic-flow-states>

